

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Cystoscopy & Ureteroscopy & Fragmentation of Stone (Lithocast)

معلومات الإقرار – نسخة المريض منظار المثانة البولية & منظار الحالب & تفتيت الحصوات

1. What do I need to know about this procedure?

A cystoscopy is where the doctor looks and examines the inside of the bladder and urethra using a fine telescopic-type instrument called a cystoscope.

If a stone is seen, it will be broken into small pieces, and removed using a fragmentation machine (lithocast). A special tube called a stent may be placed in the ureter to prevent it from blocking after the procedure. The stent will be removed later once any swelling has gone down.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See About Your Anesthetic information sheet for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung

1. ما الذي ينبغي على معرفته عن هذا الإجراء؟

منظار المثانة البولية هو إجراء يمكن من خلاله الطبيب من رؤية وفحص المثانة البولية والإحليل (قناة مجرى البول) من الداخل باستخدام أداة دقيقة من الأدوات المستخدمة في التقريب تسمى المنظار.

إذا رأى الطبيب حصوة فسيتم تفتيتها إلى أجزاء صغيرة ، ثم تتم إزالتها بواسطة جهاز تفتيت (تجزيء) . قد يوضع في الحالب أنبوب خاص يطلق عليه الدعامة لمنع انسداد الحالب بعد الإجراء . يتم لاحقاً إزالة الدعامة بعد اختفاء أي تورم.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء تخدير .
اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات ، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشتمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely damage to the urethra. A false passage may be produced causing leakage of urine or in the long term, a narrowing that may affect flow of urine.
- Damage to the bladder by puncturing the bladder wall. This may need further surgery.
- Swelling at the exit of the bladder which may result in urine retention. A tube (catheter) may need to be inserted to drain the urine until the swelling goes down.
- Bacteria may get into the blood stream with the development of septicaemia (blood infection).
- Bleeding which may stain the urine color and sometimes cause blockage of urine flow.
- Burning and scalding of urine for a few days after the procedure. This usually settles.
- The catheter may not be able to be passed through the ureteric opening and up to the kidney because of a blockage.
- Rarely, damage to ureter. A stricture may form. Very rarely an open operation may be required to repair the damage

Notes to talk to my doctor about:

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- من النادر حدوث ضرر للإحليل (قناة مجرى البول) . قد يتكون ممر خاطئ مما يتسبب في تسرب البول ، أو على المدى البعيد قد يحدث ضيق يؤثر على جريان البول.

- ضرر للمثانة البولية بسبب إحداث ثقب في جدارها . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

- تورم في مخرج المثانة البولية مما قد يؤدي إلى احتباس البول. قد تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب (قسطرة) لتصريف البول لحين تعافي التورم.

- قد تدخل البكتيريا (عدوى) إلى مجرى الدم ويحدث تسمم (تجرثم) للدم. قد تكون هناك حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.
- حدوث نزيف قد يؤدي إلى تغيير لون البول وقد يسبب أحياناً انسداد لتدفق البول.

- حرارة و حرقان في البول لعدة أيام بعد الإجراء . عادةً ما يتعافى ذلك.

- قد لا يتمكن الطبيب من تمرير القسطرة عبر فتحة الحالب صعوداً إلى الكلية بسبب وجود انسداد.

- من النادر حدوث ضرر للحالب . قد تنشأ منطقة تضيق . من النادر جداً أن تكون هناك حاجة للقيام بالفتح الجراحي من أجل إصلاح الضرر.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
